

TEMA 4.3 • GASTROENTEROLOGÍA

Malabsorción Intestinal, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **síndrome de malabsorción intestinal** es un conjunto de cuadros clínicos caracterizados por la interrupción de la secuencia fisiológica de digestión y absorción de nutrientes. Aunque puede deberse a múltiples causas, la **enfermedad celíaca** destaca como la patología paradigmática y de alta rentabilidad para el examen EUNACOM.

Síndrome de Malabsorción Intestinal: Generalidades

La clínica clásica de la malabsorción se manifiesta cuando hay un compromiso significativo de la superficie absorptiva o de la capacidad enzimática.

Manifestaciones Clínicas

- **Diarrea crónica:** Habitualmente de tipo osmótico o esteatorreico. - **Baja de peso:** A pesar de una ingesta mantenida. - **Esteatorrea:** Deposiciones con exceso de grasa (brillantes, flotan, mal olor). - **Lenteria:** Presencia de restos alimentarios no digeridos en las deposiciones. - **Signos carenciales:** - Piel seca y déficit de Vitamina A. - Queilitis angular y glositis (déficit de complejo B). - Uñas quebradizas y caída de cabello. - Anemia ferropénica (refractaria a tratamiento oral).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la D-xilosa: La D-xilosa es un monosacárido que no requiere digestión enzimática para absorberse, pero el cuerpo no puede metabolizarlo. Por lo tanto, si la mucosa intestinal está sana, la D-xilosa se absorbe y se excreta íntegramente por la orina.

Diagnóstico y Diferenciación

Para objetivar la malabsorción y orientar su etiología, se utilizan dos pruebas fundamentales:

- **Test de Sudán:** Se tiñe una muestra de deposiciones con pigmento de Sudán. La presencia de gotas de grasa confirma la **esteatorrea**.
- **Test de la D-xilosa:** Es clave para diferenciar si el problema es de la **pared intestinal** (parietal) o de las **enzimas pancreáticas**.

TABLA 4.3.1: RESULTADO TEST D-XILOSA VS INTERPRETACIÓN

RESULTADO TEST D-XILOSA	INTERPRETACIÓN	CAUSAS PROBABLES
Alterado (Baja excreción urinaria)	Problema Parietal (la pared no absorbe)	Enfermedad Celíaca, Enfermedad de Crohn, Intestino Corto.
Normal (Excreción urinaria normal)	Problema Enzimático (la pared está sana)	Pancreatitis Crónica, Fibrosis Quística.

- **Endoscopia y Biopsia Duodenal (Gold Standard):**
- Se requieren múltiples muestras del duodeno. Los hallazgos clásicos son:
- **Atrofia de vellosidades** (acortamiento o desaparición).
- **Hiperplasia de las criptas** (alargamiento compensatorio).
- **Infiltrado linfoplasmocitario** en la lámina propia (linfocitosis intraepitelial).

Tratamiento y Seguimiento

El único tratamiento es una **dieta estricta sin gluten de por vida**. - **Prohibidos:** Trigo, cebada, centeno y **avena** (la avena contiene avenina, similar al gluten, o suele estar contaminada en su procesamiento). - **Cuidado con trazas:** El paciente debe evitar alimentos procesados que no certifiquen ser "libres de gluten".

Seguimiento: Se controla con la desaparición de los síntomas y la **negativización de los anticuerpos** (habitualmente al año de dieta estricta).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si sospechas una causa infecciosa como la **Giardiasis** (que también causa malabsorción), solicita un parasitológico de deposiciones. El tratamiento de elección es **Tinidazol** o Metronidazol.

Enfermedad Celíaca

Es una enteropatía mediada por el sistema inmune, gatillada por la exposición al **gluten** en individuos genéticamente predispuestos. El gluten es una proteína presente en el **trigo, la cebada y el centeno**.

Clínica Específica

Además del síndrome de malabsorción clásico, la enfermedad celíaca puede presentarse de forma oligosintomática: - Dolor abdominal crónico y distensión. - Flatulencia y dispepsia (confundida frecuentemente con trastornos funcionales). - **Anemia ferropénica e Hipocalcemia:** Son "perlas" diagnósticas. Como el hierro y el calcio se absorben principalmente en el **duodeno** (zona más afectada por la celiaquía), su déficit aislado sin causa clara obliga a descartar esta enfermedad.

Diagnóstico

El estudio se basa en la combinación de serología y biopsia.

- **Anticuerpos (Screening):**
- - **Antitransglutaminasa tisular (tTG) IgA:** Es el examen de elección inicial por su alta sensibilidad y especificidad.
- - **Antiendomiso (EMA) IgA:** Es el mismo anticuerpo que el tTG pero medido por inmunofluorescencia; muy específico.
- - **Antigliadina y Antireticulina:** Más antiguos y menos utilizados actualmente.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Siempre se debe solicitar un nivel de **IgA total**. Los pacientes celíacos tienen mayor prevalencia de **déficit congénito de IgA**. Si el paciente no produce IgA, los anticuerpos específicos (tTG o EMA) saldrán **falsamente negativos**.

EUNACOM CRITERIOS

Si un paciente con enfermedad celíaca **no responde al tratamiento** (persisten síntomas y/o anticuerpos elevados), la causa más común es el **incumplimiento de la dieta** (voluntario o por contaminación cruzada).

Complicaciones

Si el paciente asegura cumplir la dieta, los anticuerpos están negativos, pero persiste la malabsorción y baja de peso, se debe sospechar un **Linfoma T asociado a enteropatía (Linfoma MALT)**. Esta es una complicación grave que requiere estudio imagenológico y biopsias repetidas.

Intolerancia a la Lactosa vs. Galactosemia

Es común confundir estos términos, pero sus mecanismos y gravedad son distintos.

Intolerancia a la Lactosa

- **Fisiopatología:** Déficit de la enzima **lactasa** en el ribete en cepillo del intestino delgado. Es común en adultos. - **Clínica:** Diarrea osmótica, meteorismo y dolor abdominal tras ingerir lácteos. **No produce esteatorrea.** - **Diagnóstico:** Test de hidrógeno espirado o prueba de tolerancia a la lactosa oral (la glicemia no sube tras la ingesta). - **Tratamiento:** Dieta pobre en lactosa o uso de suplementos de lactasa. La "leche sin lactosa" comercial es en realidad leche con lactasa añadida.

Galactosemia

- **Fisiopatología:** Enfermedad genética autosómica recesiva. Falta la enzima para metabolizar la **galactosa** (producto de la degradación de la lactosa). - **Clínica (Grave):** Se presenta en el recién nacido con ictericia, daño hepático crónico, falla renal, retraso mental y **cataratas.** - **Tratamiento:** Eliminación total de la galactosa. **Está contraindicada la lactancia materna** y las fórmulas animales. Se debe usar leche de soya (origen vegetal).

TABLA 4.3.2: CARACTERÍSTICA VS INTOLERANCIA A LA LACTOSA		
CARACTERÍSTICA	INTOLERANCIA A LA LACTOSA	GALACTOSEMIA
Edad de inicio	Habitualmente adultos	Recién nacido / Lactante
Gravedad	Leve (molestias GI)	Grave (daño multiorgánico)
Hallazgo clave	Meteorismo y diarrea	Cataratas, ictericia, retraso
Lactancia Materna	Permitida (según tolerancia)	Contraindicada
Leche sin lactosa	Útil	Prohibida (contiene galactosa)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: La **galactosemia** es una urgencia metabólica neonatal que se trata con leche de soya, mientras que la **intolerancia a la lactosa** es un cuadro funcional del adulto.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 30 años con diarrea crónica, baja de peso y anemia ferropénica que no responde a hierro oral. Se realiza test de D-xilosa que resulta alterado. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Malabsorción Intestinal, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Malabsorción: diarrea, baja de peso, esteatorrea, lentería y signos carenciales; test de Sudán confirma esteatorrea
- Test de D-xilosa alterado = problema parietal (celíaca, Crohn); normal = problema enzimático (pancreático)
- Enfermedad celíaca: reacción inmune al gluten (trigo, cebada, centeno, avena); diagnóstico con antitransglutaminasa + biopsia duodenal
- Biopsia duodenal celíaca: atrofia vellositaria, alargamiento de criptas, infiltrado linfoplasmocitario
- Pedir IgA junto con anticuerpos celíacos (riesgo de falso negativo por déficit de IgA asociado)
- Tratamiento celíaca: dieta sin gluten estricta; control con anticuerpos que negativizan al año
- Falta de respuesta con anticuerpos negativos: sospechar linfoma MALT
- Galactosemia: enfermedad genética con cataratas, daño hepático y retardo mental; tratamiento con leche de soya exclusivamente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MALABSORCIÓN INTESTINAL, ENFERMEDAD CELÍACA E INTOLERANCIA A LA LACTOSA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años con diarrea crónica, baja de peso y anemia ferropénica que no responde a hierro oral. Se realiza test de D-xilosa que resulta alterado. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?

- A)** Pancreatitis crónica
- B)** Fibrosis quística
- C)** Enfermedad celíaca
- D)** Intolerancia a la lactosa
- E)** Síndrome de intestino irritable

PREGUNTA 2

Paciente con enfermedad celíaca en tratamiento con dieta sin gluten hace 1 año. Refiere seguir la dieta estrictamente pero persiste con diarrea. Los anticuerpos antitransglutaminasa están negativos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- A)** Mala adherencia a la dieta
- B)** Linfoma MALT
- C)** Intolerancia a la lactosa asociada
- D)** Síndrome de intestino irritable
- E)** Giardiasis

PREGUNTA 3

Recién nacido con ictericia, hepatomegalia, cataratas bilaterales y retardo en el desarrollo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Leche materna exclusiva
- B)** Leche sin lactosa
- C)** Leche de soya
- D)** Fórmula hidrolizada
- E)** Suplemento de lactasa

RESUMEN: MALABSORCIÓN INTESTINAL, ENFERMEDAD CELÍACA E INTOLERANCIA A LA LACTOSA

Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. La malabsorción se presenta con diarrea, baja de peso, esteatorrea, lentería y signos carenciales, diagnosticándose con test de Sudán (confirma esteatorrea) y test de D-xilosa (diferencia causa parietal vs enzimática). La enfermedad celíaca es una reacción inmune al gluten (trigo, cebada, centeno, avena). Se diagnostica con anticuerpos antitransglutaminasa/antiendomiso y biopsia duodenal (atrofia vellositaria, alargamiento de criptas, infiltrado linfoplasmocitario). El tratamiento es dieta estricta sin gluten, controlada con clínica y anticuerpos. Se diferencia la intolerancia a la lactosa (déficit de lactasa, diarrea sin esteatorrea, dieta sin lactosa) de la galactosemia (enfermedad genética recesiva con daño hepático, cataratas y retardo mental, tratada con leche de soya).